Aspectos generales del dolor oncológico. Situación actual del dolor oncológico en nuestro entorno

Dolor oncológico

tech

CONTENIDO

1. Introducción
2. Multidimensionalidad del dolor oncológico
3. Epidemiología del dolor oncológico
4. Prevalencia del dolor oncológico según localización
5. Prevalencia del dolor oncológico según fase de la enfermedad
6. Prevalencia de dolor oncológico según tratamiento oncológico recibido
7. Barreras que impiden un adecuado manejo del dolor
8. Bibliografía

Introducción

El dolor es un síntoma altamente prevalente en pacientes con cáncer. A pesar de los avances terapéuticos y las pautas de tratamiento bien aceptadas, un porcentaje de pacientes con dolor no recibe tratamiento suficiente. Actualmente se ha reconocido que todavía existen varias barreras en el manejo del dolor y, además, existen nuevos desafíos en torno a los subtipos complejos de dolor, como el dolor neuropático, que requieren más revisiones y recomendaciones.

Multidimensionalidad del dolor oncológico

Se define el dolor como una "experiencia sensorial y emocional desagradable que, en general, se asocia con una lesión presente o potencial que se expresa como si existiera".

En el año 2016, la Asociación internacional para el estudio del dolor (IASPS) aceptó una nueva definición de dolor en la que se recogen aspectos sensoriales, emocionales y cognitivos, que hasta ese momento habían estado ausentes en las definiciones de dolor.

Este cambio en la definición hace referencia a la emoción que experimenta el paciente ante cualquier daño real o potencial, cómo integra esta emoción según su aprendizaje previo y la socialización individual. De esta forma, se pone de manifiesto la variabilidad intersujeto en la percepción y afrontamiento del dolor.

Desde este punto se puede pensar que el tratamiento del dolor no solo consiste en el empleo de uno u otro fármaco, sino que también implica atención psicológica y social.

Siguiendo esta línea, en 1968, Melzack y Casey propusieron tres dimensiones de la experiencia dolorosa. Cada una de estas confiere al dolor una serie de características especiales, pero interrelacionadas, de tal forma que la experiencia de dolor no puede entenderse de forma completa si no se tienen en cuenta todas ellas.

- **Dimensión sensorial-discriminativa:** estaría directamente relacionada con los mecanismos anatomofisiológicos. Sería la encargada de la transmisión de la estimulación nociceptiva desde la región donde se haya producido un daño tisular, infección o cualquier otra alteración orgánica o funcional hasta los centros nerviosos superiores. Tal dimensión es la responsable de la detección de las características espaciales y temporales del dolor, así como de la intensidad y ciertos aspectos de la cualidad del dolor (distinción entre dolor urente, opresivo, etc.), parámetros de especial relevancia para el diagnóstico de la patología que produce el dolor (neurológica, traumatismo, infecciosa, psicógena, etc.).

  Los procedimientos de intervención que se basan en la dimensión sensorial-discriminativa son las técnicas biomédicas tradicionales.

  Los analgésicos (quizá el más utilizado de todos los tipos de intervención) pueden incidir en tres niveles: a nivel receptorial, disminuyendo la capacidad de estimulación de los nociceptores (analgésicos como el paracetamol); a nivel de conducción (anestésicos locales como la lidocaína); o a nivel central (opiáceos).

  Otros procedimientos comunes son la Estimulación Nerviosa Transcutánea (TENs), bloqueos nerviosos, cirugía estereotáxica, cordotomía, etc.

- **Dimensión motivacional-afectiva:** implica la cualidad subjetiva de la experiencia de dolor, en concreto en los aspectos de sufrimiento, aversión, desagrado o cambios emocionales producidos. Algunas de las reacciones emocionales que están más directamente relacionadas con el dolor son ansiedad y depresión, de las que posteriormente se verá poco más detenidamente. Debido al componente aversivo al dolor se producen conductas de evitación o escape, que tendrán una especial significación para el mantenimiento de las conductas de dolor y de la propia experiencia dolorosa.

  Los procedimientos más utilizados son técnicas psicológicas en las que se evite esta dimensión aversiva.

  Las técnicas más características son sugestión, hipnosis, imaginación. *Biofeedback*, etc.

- **Dimensión cognitivo-evaluativa:** directamente relacionada con la motivacional-afectiva y hace referencia a las creencias, valores culturales y variables cognitivas, tales como autoeficacia, percepción de control y de las consecuencias de la experiencia de dolor, etc.

  Las técnicas psicológicas de control del dolor preparan al paciente para que experimente el dolor sin catastrofismos y que sea capaz de utilizar las estrategias de afrontamiento más adecuadas. Ello conlleva, evidentemente, a que sus reacciones emocionales ante el dolor no sean tan aversivas, lo que redundará en mayor eficacia de las estrategias cognitivas para el control del dolor, etc *(figura 1)*.

Epidemiología del dolor oncológico

El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad del mundo, con aproximadamente 18,1 millones de casos nuevos en el mundo en el año 2018.

Las estimaciones poblacionales indican que el número de casos nuevos aumentará en las dos próximas décadas hasta 29,5 millones al año en 2040.

Los tumores más frecuentemente diagnosticados en el mundo en el año 2018 fueron los de pulmón, mama, colon y recto, próstata y estómago.

También en España, el cáncer es una de las principales causas de morbi-mortalidad. El número de cánceres diagnosticados en España en el año 2020 se estima que alcanzará los 277 394 casos según los cálculos de REDECAN, un número muy similar al del año 2019.

Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en 2020 serán los de colon y recto (44 231 nuevos casos), próstata (35 126), mama (32 953), pulmón (29 638) y vejiga urinaria (22 350). A mucha distancia, los siguientes cánceres más frecuentes serán los linfomas no hodgkinianos (9188) y los cánceres de cavidad oral y faringe (8604), páncreas (8338), estómago (7577), riñón (7300) y cuerpo uterino (6804).

El número absoluto de cánceres diagnosticados en España ha continuado en aumento desde hace décadas en probable relación con el aumento poblacional (la población de España creció en 163 336 personas durante la primera mitad de 2019 y se situó en 47 100 396 habitantes), el envejecimiento de la población (la edad es un factor de riesgo fundamental en el desarrollo del cáncer), la exposición a factores de riesgo (como el tabaco, el alcohol, la contaminación, la obesidad, el sedentarismo entre otros muchos) y, en algunos tipos de cáncer como el colorrectal, los de mama, cérvix o próstata, el aumento de la detección precoz. De hecho, si los programas de detección precoz son adecuados, deberían conducir a un aumentodel número de casos, pero también una reducción de la mortalidad. Debido a la combinación de estos factores, se puede dar el caso de que a pesar de que la exposición a factores de riesgo no varíe a lo largo del tiempo, el número absoluto de casos aumente debido a los otros dos factores (aumento poblacional y/o envejecimiento).

La prevalencia de tumores en España, según los últimos datos aportados por el informe Sociedad Española de Oncología Médica (SEOMS) "Las cifras del Cáncer 2020" *(figura 2).*

En pacientes con cáncer, el dolor es uno de los síntomas más temidos y pesados. Los primeros informes sobre la prevalencia del dolor en pacientes con cáncer llaman la atención sobre cifras altas que oscilaron entre 52 % y 77 %. Estudios más recientes sobre la prevalencia del dolor en pacientes con cáncer mostraron cifras que oscilaron entre 24 % y 60 % en pacientes en tratamiento activo contra el cáncer y entre el 62 % y 86 % en pacientes con cáncer avanzado. Estas cifras no llevan a la conclusión de que este problema no se ha resuelto.

Estas cifras de alta prevalencia contrastan notablemente con el creciente interés por el dolor y el alivio del dolor en la última década. Aparentemente, una mayor comprensión de los mecanismos fisiopatológicos del dolor y la mayor disponibilidad de terapias antinociceptivas, como opioides, coanalgésicos y antagonistas de los receptores de NMDA (ácido N-metil-D-aspártico), no han influido en la prevalencia del dolor en pacientes con cáncer. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) introdujo una escala de dolor en 1986 que ha sido aceptada en todo el mundo. En combinación con las pautas de dosificación apropiadas, debería ser capaz de proporcionar herramientas para el alivio adecuado del dolor en 70 % a 90 % de los pacientes.

Prevalencia del dolor según localización del cáncer

En la literatura se puede encontrar diferentes cifras donde se muestra la prevalencia de dolor según el tipo de cáncer. Algunos tipos específicos asocian tasas de prevalencia particularmente altas de dolor neuropático, mientras que la metástasis ósea es la causa más común de dolor relacionado con el cáncer.

Estos datos pueden variar dependiendo de la situación geográfica, edad del paciente y tipo de terapias empleadas para el control de la enfermedad oncológica.

Según la revisión de la prevalencia de cáncer realizada por van den Beuken-van Everdingen, MHJ y cols., la prevalencia según la localización es *(figura 3):*

- Cánceres de cabeza y cuello: 70 %
- Cáncer ginecológico y gastrointestinal: 60 %
- Cáncer de pulmón 59 %
- Cáncer de bronquios 55 %
- Cáncer de mama 54 %
- Cáncer urotelial 52 %

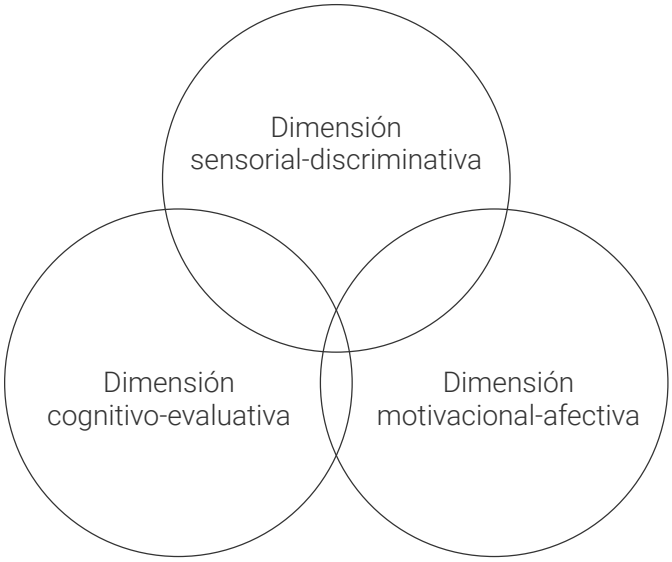

Figura 1. Dimensiones del dolor.

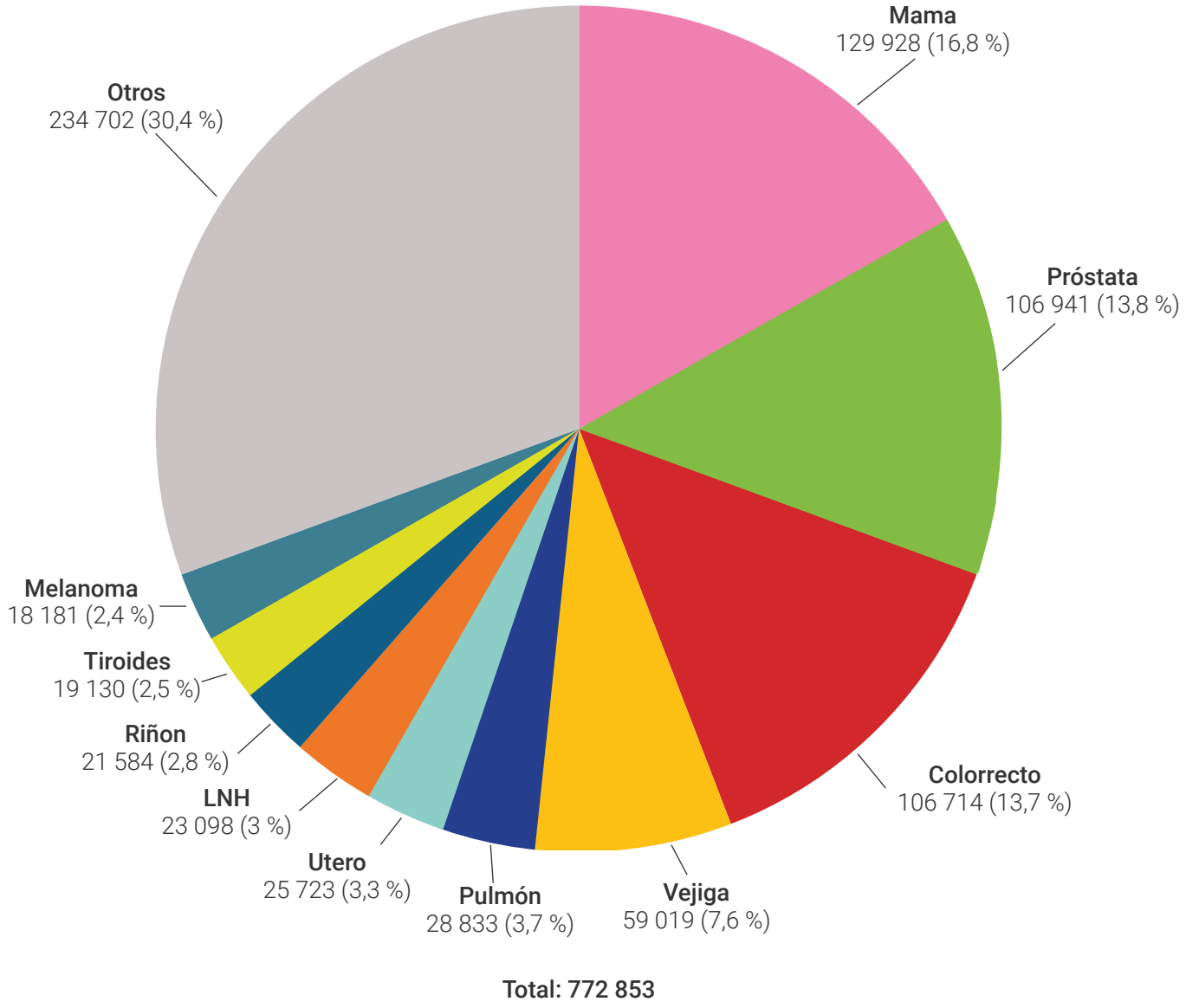

Figura 2. Estadística de cánceres diagnosticados.

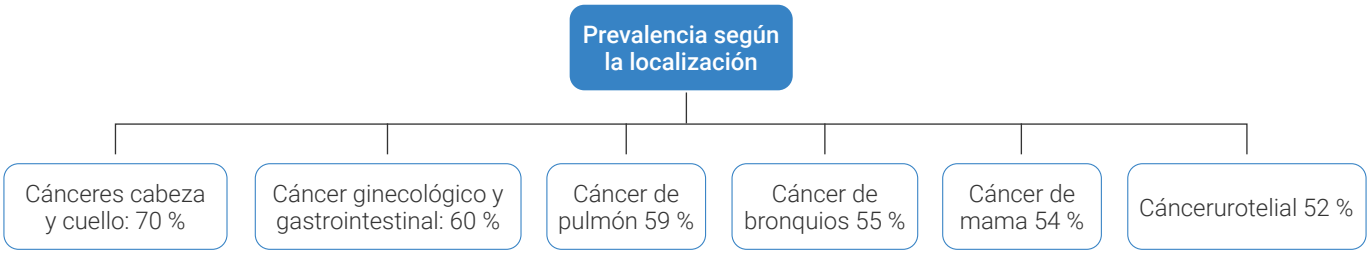

Figura 3. Prevalencia según la localización.

Prevalencia del dolor según fase de la enfermedad

También se pueden encontrar diferencias en la prevalencia a lo largo del curso de la enfermedad, siendo más frecuente en las fases tardías del proceso oncológico.

La progresión de la enfermedad oncológica implica en un elevado porcentaje la invasión de estructuras óseas, de elementos vasculares o nerviosos, la infiltración de vísceras huecas.

Estos cambios se traducen en un aumento de prevalencia de dolor en el paciente oncológico.

La prevalencia del dolor depende de la fase en la que se encuentre la enfermedad *(figura 4)*:

- 64 % de los pacientes con enfermedad avanzada, metastásica o terminal
- 59 % de los pacientes en tratamiento para el cáncer

Prevalencia según fase de la enfermedad			
64% de los pacientes con enfermedad metastásica o terminal.	59% de los pacientes en tratamiento para el cáncer.	53% independientemente de su fase.	35% de los pacientes en fase de resolución completa.

Figura 4. Prevalencia según fase de la enfermedad.

- 53 % independientemente de su fase
- 35 % de los pacientes en fase de resolución completa o curativa de su enfermedad

Prevalencia de dolor oncológico según tratamiento oncológico recibido

Por otra parte, se puede relacionar el dolor experimentado en los pacientes oncológicos con el tratamiento recibido para su enfermedad. Así, los pacientes de forma iatrógena, experimentan dolor relacionado con la intervención quirúrgica, la quimioterapia (mucositis gastrointestinal y bucofaríngea, neurotoxicidad) o la radioterapia (enteritis, cistitis, osteonecrosis).

En mujeres sometidas a mastectomía por cáncer, el índice de dolor varía del 20 al 65 %. La mayoría situaba el dolor en la axila/brazo (80,8 %), en la zona de la cicatriz (55,8 %) y 75 % en más de una ubicación.

Dentro de los agentes que se manejan para el tratamiento de cáncer de mama se encuentran los taxanos, los agentes de platino y los alcaloides de la vinca, los cuales se relacionan con la mayoría de las manifestaciones de dolor neuropático en este tipo de pacientes. La radioterapia también se relaciona con el dolor neuropático, principalmente por la afección del plexo braquial a nivel de la fosa supraclavicular hasta en un 33 % de las mujeres tratadas.

Los pacientes con cáncer de pulmón generalmente mueren al año de su diagnóstico (80-90 %). El dolor se presenta en el 11 % de ellos, con algunas variaciones consideradas dependiendo del estadio de la tumoración, siendo más frecuente el dolor nociceptivo (73 %, rango de 75-86 %) que el dolor neuropático que ocurre en el 30 % de los casos.

Entre el 50 % y el 80 % de los pacientes sometidos a toracotomía experimentan dolor crónico severo hasta varios meses después del procedimiento, y el 30% de ellos puede aún tener dolor durante los 4 o 5 años posteriores a la cirugía con un dolor neuropático reportado como el más frecuente.

En un estudio de 48 pacientes con adenocarcinoma pancreático localmente avanzado e irresecable, que recibieron radioterapia, capacitabine y bevacizumab, donde 42 % de ellos fueron hombres, el 69 % de los tumores estaban localizados en la cabeza del páncreas, el 13 % en el cuerpo de éste, 8 % en el cuello y 10 % en múltiples sitios. El 94 % de los tumores fueron irresecables por comprometer el plexo celíaco o la arteria mesentérica superior, 74 % de los pacientes presentaron comorbilidades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, hepáticas o renales. En cuanto al dolor, se presentaba en el 13 % de los pacientes posterior al tratamiento contra 19 % que lo mencionaban antes de la radioquimioterapia.

En tumores de cabeza y cuello, la cirugía induce dolor en el 52 % de los pacientes, además de pérdida de la función. La duración promedio del dolor tanto neuropático como somático es de 1 a 92 semanas con una media de 26,9.

En tumores óseos o en donde se compromete una extremidad, la amputación se relaciona con una prevalencia de dolor en un 60 %, con presencia de miembro fantasma desde semanas hasta meses posteriores a la cirugía, aunque se ha llegado a documentar su aparición hasta varios años después.

La radiación de la próstata y los carcinomas cervicales y de endometrio se relacionan a proctitis en 2 % a 5 % de los sobrevivientes, sin demostrarse relaciones entre la proctitis aguda y el desarrollo de dolor crónico *(figura 5).*

Barreras que impiden un adecuado manejo del dolor

A pesar del tremendo progreso en el conocimiento sobre el dolor relacionado con el cáncer y su tratamiento, estudios recientes han demostrado que el dolor no se controla adecuadamente en hasta el 31 % de los casos.

Se han reconocido barreras para el manejo adecuado del dolor, tanto a nivel de pacientes como de los profesionales y el sistema.

Barreras dependientes del paciente *(figura 6):*

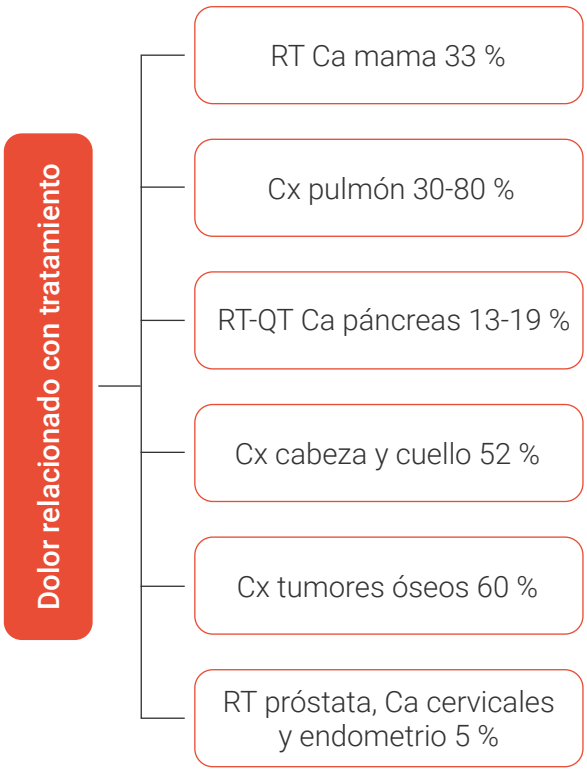

Figura 5. Dolor relacionado con tratamiento.

- Se resiste a informar sobre su dolor.
- Escaso cumplimiento terapéutico
- Alteraciones cognitivas y estrés afectivo que limitan la información.
- Temor a la adicción o desarrollo de tolerancia
- Temor a los efectos secundarios
- Esfuerzos por ser un "buen paciente" tolerando el dolor.
- Creencia de que el doctor debe centrarse en el tratamiento del cáncer en lugar de aliviar su dolor.
- Preocupación sobre la impresión negativa de la familia, amigos, si el paciente utiliza medicación para el dolor.
- Estoicismo o fatalismo sobre la enfermedad
- Creencia de que el dolor no puede ser mejor tratado.
- Problemas para financiar el tratamiento analgésico.

Barreras dependientes del profesional *(figura 7):*

- Escasa comunicación acerca del dolor que sufre el paciente.
- Preferencia del uso de analgésicos no potentes
- Fallo en la evaluación del dolor o en el uso rutinario de herramientas que miden el dolor.
- Conocimiento no adecuado sobre el manejo del dolor
- Falta de tiempo en la evaluación del paciente
- Excesiva preocupación sobre los efectos secundarios de los opioides, depresión respiratoria y adicción
- Falta de multidisciplinaridad

Bibliografía

1. Van den Beuken-van Everdingen, MHJ y col. Prevalencia del dolor en pacientes con cáncer: una revisión sistemática de los últimos 40 años. Annals of Oncology; 2007. Volumen 18, Número 9; 1437 – 1449.
2. GLOBOCAN. Incidencia y mortalidad por cáncer en todo el mundo: IARC CancerBase. Disponible en Global Cancer Observatory: http://gco.iarc.fr; 2018.
3. REDECAN — Red Española de Registros de Cancer. http://redecan.org/is
4. SEOM, Las cifras del Cáncer en España; 2020.
5. Romero, J., Plancarte, A., Guerrero, G., Amezcua, C., Liceaga, M., & Allende, S. Prevalencia del dolor por cáncer en una población de pacientes de nuevo ingreso en el Instituto Nacional de Cancerología. J Pain Symptom Manage; 1998. 3, 571-577.
6. Pargeon, KL y Hailey, BJ. Barreras para el manejo efectivo del dolor por cáncer: una revisión de la literatura. Diario de dolor y manejo de síntomas; 1999. 18 (5), 358-368.